Protocolli in sintesi

Consultazione rapida: per ogni protocollo, la pagina dello script operativo e del riquadro di sintesi.

6 **Il paziente che non usa gli allineatori** SCRIPT **13** PROTOCOLLO **17**

CAPITOLO

6

Il paziente che non usa gli allineatori

«Fare bene vale più che dire bene.»

— BENJAMIN FRANKLIN

Ci sono situazioni nelle quali basta osservare gli allineatori in bocca per rendersi conto che qualcosa non sta procedendo come avevamo programmato, ma non tutte le perdite di fitting hanno lo stesso significato e, soprattutto, non tutte richiedono la stessa risposta clinica.

Se un singolo dente non segue perfettamente l'allineatore, non penso automaticamente a un problema di collaborazione e non interrompo necessariamente la sequenza per eseguire una nuova scansione. Sappiamo bene che alcuni movimenti sono meno predicibili di altri: un incisivo laterale superiore che deve eseguire una rotazione complessa, un'estrusione difficile o un altro movimento particolarmente

impegnativo può rimanere indietro anche in un paziente che utilizza gli allineatori in maniera impeccabile. Se quel movimento non è strategico per la prosecuzione della terapia e la sua mancata espressione non compromette i movimenti successivi, molto spesso preferisco continuare con la sequenza programmata e recuperarlo successivamente durante la fase di rifinitura.

La situazione cambia quando la perdita di fitting non riguarda più un singolo dente, ma comincia a diventare generalizzata. **Per questo motivo il primo controllo durante la sequenza lo programmo normalmente dopo circa due mesi.** È un intervallo che considero sufficientemente lungo per capire come il paziente stia realmente utilizzando gli allineatori e per iniziare a osservare un'eventuale perdita di fitting, ma allo stesso tempo abbastanza breve da permettermi, nella maggior parte dei casi, di intervenire prima che la discrepanza diventi troppo importante. Se a quel controllo mi accorgo che diversi denti stanno iniziando a rimanere indietro rispetto alla posizione programmata, spesso siamo ancora nelle condizioni di recuperare il fitting modificando il comportamento del paziente o rallentando temporaneamente la sequenza, senza essere costretti a interrompere tutto ed eseguire una nuova scansione.

Quando a questo primo controllo osservo una perdita di fitting che non riguarda più un singolo movimento, ma coinvolge progressivamente più denti, il sospetto che il paziente non stia utilizzando gli allineatori per il numero di ore necessario diventa inevitabilmente molto forte. È proprio in quel momento che inizia uno dei problemi di comunicazione più frequenti nel trattamento con allineatori e, per capire cosa stia succedendo, comincio con una domanda molto semplice:

> *«Come sta andando con gli allineatori? Qual è il momento della giornata in cui fai più fatica a rimetterli?»*

Questa domanda mi aiuta più di un generico «*Riesci a utilizzarli sempre?*», al quale il paziente tende quasi inevitabilmente a rispondere di sì. Cerco allora di ricostruire meglio quello che succede durante una normale giornata, chiedendo quando li toglie, quanto durano i pasti, cosa succede durante il lavoro, quando esce la sera o nel fine settimana. Presto particolare attenzione al tempo che trascorre tra la fine del pasto e il momento in cui gli allineatori vengono effettivamente reinseriti, perché spesso è proprio lì, più che durante il pasto stesso, che si accumulano le ore senza allineatori.

Non lo faccio come un interrogatorio, ma cercando di capire insieme al paziente se esistano momenti nei quali, senza rendersene conto, il tempo trascorso senza

allineatori sia maggiore di quanto percepisca. Alla fine, però, può capitare che continui a essere assolutamente sicuro della propria risposta:

«No, dottore. Li utilizzo davvero sempre.»

A quel punto mi trovo davanti a due informazioni che sembrano difficili da conciliare: da una parte quello che vedo clinicamente mi suggerisce che i denti non stanno seguendo gli allineatori come dovrebbero, mentre dall'altra ho davanti una persona che mi assicura con grande convinzione di avere seguito scrupolosamente tutte le indicazioni ricevute.

Il comportamento che dobbiamo modificare

Il comportamento sul quale vogliamo intervenire non è genericamente *"collaborare di più"*. Dobbiamo fare in modo che il paziente utilizzi gli allineatori per il numero di ore necessario, riducendo soprattutto quei periodi della giornata nei quali rimangono fuori dalla bocca più a lungo di quanto lui stesso percepisca.

Questo è importante perché molto spesso il problema non nasce da una decisione consapevole di utilizzare poco gli allineatori, ma dalla somma di molti intervalli apparentemente insignificanti: una colazione che dura più del previsto, il caffè dopo pranzo, una telefonata prima di rimetterli, un aperitivo, una cena che si prolunga o semplicemente il fatto di lasciarli sul tavolo e ricordarsene un'ora dopo. Presi singolarmente sembrano episodi trascurabili; sommati nell'arco della giornata possono ridurre in maniera importante il tempo reale di utilizzo.

Per questo il primo obiettivo non è stabilire se il paziente stia dicendo la verità, ma trasformare un generico *«li utilizzo sempre»* in una descrizione sufficientemente concreta della sua giornata da permetterci di capire dove possa trovarsi il problema.

L'errore che facevo: cercare di convincere il paziente

Di fronte a queste situazioni sceglievo il modo che mi sembrava più semplice e logico. Se vedevo una perdita generalizzata di fitting, spiegavo al paziente che probabilmente non stava utilizzando gli allineatori abbastanza e insistevo sulla necessità di aumentare le ore di utilizzo. Gli mostravo quello che vedevo clinicamente e gli dicevo qualcosa come:

«Guarda che qui si vede chiaramente che i denti non stanno seguendo gli allineatori. Devi cercare di utilizzarli di più.»

Il problema era che dall'altra parte ricevevo quasi sempre la stessa risposta:

«Ma io li utilizzo.»

Io vedevo l'unfitting e insistevo, mentre il paziente ribadiva di avere seguito le indicazioni. Più cercavo di convincerlo che il problema fosse la sua collaborazione, più lui sentiva il bisogno di difendere il proprio comportamento e, dopo qualche minuto, ci trovavamo a discutere non più di come recuperare il trattamento, ma di chi dei due avesse ragione.

Questa dinamica può diventare ancora più evidente quando davanti abbiamo un paziente adulto molto sicuro di sé, magari una persona con un ruolo professionale importante, abituata a prendere decisioni, a dirigere altre persone e a sostenere con fermezza le proprie posizioni. Dire apertamente a quel paziente «*Non è vero, gli allineatori non li stai utilizzando*» significa mettere in discussione non soltanto la sua collaborazione, ma anche la sua credibilità.

A quel punto il problema clinico rischia di trasformarsi in uno scontro personale nel quale entrambi cerchiamo, più o meno consapevolmente, di dimostrare di avere ragione. Il paradosso è che, anche se riuscissi a vincere quella discussione, non avrei necessariamente ottenuto ciò che mi interessa davvero, perché il mio obiettivo non dovrebbe essere convincere il paziente che ha sbagliato nelle settimane precedenti, ma fare in modo che utilizzi correttamente gli allineatori da quel momento in avanti.

Ci ho messo del tempo a capirlo e, probabilmente, ho avuto bisogno di una paziente particolare per cambiare completamente prospettiva.

La paziente alla quale non credevo

Avevo trattato con gli allineatori prima il marito e successivamente i due figli di Chantal. Tutti e tre erano stati molto collaboranti e i loro trattamenti si erano conclusi senza particolari difficoltà, così quando anche lei decise di sistemare i denti non avevo nessun motivo per aspettarmi qualcosa di diverso. Il suo era, almeno apparentemente, un caso molto semplice, con un po' di affollamento soprattutto a livello degli incisivi inferiori e niente che, dal punto di vista biomeccanico, mi facesse immaginare particolari difficoltà.

Iniziammo il trattamento e già durante i primi controlli mi resi conto che qualcosa non stava andando come previsto, perché gli incisivi si muovevano molto meno di quanto mi sarei aspettato e gli allineatori progressivamente perdevano fitting. Lei lavorava nel mondo della moda, viaggiava moltissimo e aveva una vita professionale particolarmente intensa e ricca di eventi, aperitivi e altri momenti conviviali durante i quali è facile dimenticarsi degli allineatori. Per questa ragione, nella mia testa, la spiegazione sembrava quasi ovvia: semplicemente non li utilizzava abbastanza.

Cominciai quindi a insistere sulla collaborazione, ricordandole che gli allineatori dovevano essere utilizzati per il numero di ore prescritto e spiegandole che, se continuava in quel modo, i denti non avrebbero seguito correttamente la programmazione. Lei, però, continuava a ripetermi la stessa cosa:

«Enzo, io li utilizzo.»

Io continuavo a guardare quegli incisivi e continuavo a non crederle. La situazione andò avanti per più di sei mesi, fino a quando Chantal mi disse che dopo qualche mese si sarebbe trasferita a Londra per lavoro e mi chiese di concludere il trattamento prima della sua partenza. A quel punto pensai di eliminare definitivamente quella che, nella mia testa, continuava a essere la causa principale del problema e le proposi di mettere dei bracket sugli incisivi inferiori, promettendole che in un paio di mesi si sarebbero perfettamente allineati. Ero abbastanza tranquillo, perché ero convinto che, una volta eliminata la variabile della collaborazione, quei pochi denti si sarebbero allineati rapidamente.

Dopo due mesi gli incisivi erano ancora storti.

Fu probabilmente la prima volta in cui presi davvero in considerazione una possibilità che fino a quel momento avevo quasi escluso: forse quella paziente non mi aveva mai mentito e il problema che avevo attribuito per mesi alla sua collaborazione poteva dipendere, almeno in parte, dalla sua risposta biologica al movimento ortodontico.

Non in tutti i pazienti i denti si muovono alla stessa velocità

Quell'esperienza mi spinse a interessarmi maggiormente alla variabilità individuale del movimento ortodontico e scoprii che ciò che avevo osservato clinicamente aveva una base biologica molto più solida di quanto avessi immaginato.

Quando applichiamo una forza ortodontica, infatti, non stiamo spostando meccanicamente un dente come potremmo spostare un oggetto. La forza rappresenta lo stimolo iniziale di una complessa risposta biologica che coinvolge il legamento parodontale, l'osso alveolare, osteoclasti, osteoblasti, mediatori dell'infiammazione e numerosi meccanismi cellulari e molecolari. La velocità con cui questa risposta avviene presenta una considerevole variabilità individuale e, anche quando cerchiamo di standardizzare la forza applicata, persone differenti possono mostrare velocità di movimento molto diverse.

Uno degli studi che meglio dimostra questo fenomeno è stato pubblicato da Giannopoulou e collaboratori sull'*European Journal of Orthodontics*. Gli autori applicarono un protocollo sperimentale standardizzato nel quale due premolari di cia-

scun partecipante venivano spostati vestibolarmente per otto settimane utilizzando una forza di 1 N. Nonostante la forza fosse standardizzata e fossero stati esclusi ostacoli locali o funzionali al movimento, la quantità di spostamento ottenuta variò enormemente tra gli individui, passando da appena 0,6 mm fino a 5,8 mm, con una media di 2,7 mm. Ancora più interessante fu osservare che i denti appartenenti allo stesso individuo tendevano a comportarsi in maniera simile, mostrando un'elevata correlazione intraindividuale. Gli stessi autori conclusero che questa ampia variabilità permetteva di identificare, all'interno del campione, soggetti *slow movers* e *fast movers*.

Il concetto è stato ripreso anche in studi clinici successivi. In un trial randomizzato sulla chiusura degli spazi estrattivi, per esempio, gli autori utilizzarono esplicitamente le espressioni *fast movers* e *slow movers* per distinguere pazienti che, nello stesso intervallo temporale, mostravano quantità differenti di movimento dentale. In quello specifico studio furono definiti *fast movers* i casi con un movimento di almeno 1 mm al mese. Naturalmente questa soglia non rappresenta una definizione universale da trasferire alla pratica clinica e non ci consente di dividere semplicemente tutti i nostri pazienti in due categorie, ma dimostra quanto il concetto di una diversa velocità individuale di movimento sia reale e utilizzato nella stessa letteratura ortodontica.

Le ragioni di questa variabilità sono probabilmente molteplici e non ancora completamente comprese. Il movimento ortodontico dipende dalla risposta biologica dei tessuti alla forza e sono state studiate differenze individuali nei sistemi molecolari coinvolti nel rimodellamento osseo e del legamento parodontale. Alcune ricerche hanno indagato anche il possibile contributo genetico e, in particolare, polimorfismi di geni coinvolti nei sistemi RANK, RANKL e OPG e in altri mediatori della risposta ortodontica. È interessante che anche in questo ambito gli autori facciano esplicitamente riferimento al fenomeno clinico degli *slow movers* e dei *fast movers*, ipotizzando che almeno una parte della diversa velocità di movimento possa dipendere dalle caratteristiche biologiche del singolo individuo.

Questa variabilità biologica, naturalmente, esisteva anche quando i nostri trattamenti venivano eseguiti con apparecchiature fisse. In quel contesto, però, uno *slow mover* rappresentava soprattutto un problema di tempo. Se un dente non aveva ancora raggiunto la posizione desiderata, nella maggior parte dei casi potevamo semplicemente lasciare lavorare più a lungo lo stesso arco e aspettare che la risposta biologica facesse il proprio corso. Come mi ha sempre detto il mio grande maestro Davide Mirabella: «*Let them cook.*» Lasciali cucinare. A volte la cosa migliore da fare era semplicemente dare ai denti il tempo necessario per esprimere il movimento.

Il fatto che quel paziente avesse bisogno di più tempo non ci obbligava necessariamente a modificare la sequenza terapeutica: potevamo adattare il ritmo del trattamento alla velocità con cui i suoi denti si stavano realmente muovendo.

Con gli allineatori il problema assume una dimensione diversa, perché non è più soltanto una questione di quanto tempo impiega il dente a muoversi, ma di quanto la sua velocità biologica riesca a rimanere sincronizzata con la sequenza programmata. Ogni allineatore viene progettato presupponendo che il movimento previsto dall'allineatore precedente sia stato sufficientemente espresso. Se il paziente è uno *slow mover* e noi continuiamo a sostituire gli allineatori secondo un intervallo troppo rapido rispetto alla sua risposta biologica, il dente può progressivamente rimanere indietro rispetto alla posizione prevista. L'allineatore successivo cerca allora di adattarsi a una posizione che il dente non ha ancora raggiunto e questa discrepanza, cambio dopo cambio, può accumularsi fino a diventare clinicamente evidente sotto forma di perdita di fitting.

È probabilmente questa una delle ragioni per cui il concetto di *slow mover*, pur non essendo affatto nuovo, diventa particolarmente rilevante nella terapia con allineatori. Con l'apparecchiatura fissa potevamo spesso permetterci semplicemente di aspettare più a lungo; con gli allineatori dobbiamo invece cercare di sincronizzare la velocità con cui facciamo avanzare la sequenza con la velocità con cui la biologia di quel paziente è realmente in grado di esprimere il movimento.

Tutto questo non significa naturalmente che una perdita generalizzata di fitting debba essere automaticamente attribuita alla biologia, né che lo *slow mover* rappresenti la spiegazione più probabile ogni volta che un trattamento con allineatori non procede come previsto. La collaborazione rimane una delle prime variabili da prendere in considerazione quando diversi denti iniziano contemporaneamente a perdere fitting. La letteratura sugli *slow movers* ci ricorda però qualcosa di altrettanto importante: dalla sola osservazione clinica non possiamo sempre sapere con certezza quanto ciò che stiamo vedendo dipenda dal comportamento del paziente e quanto possa invece essere influenzato dalla sua risposta biologica individuale.

Chantal, alla fine, mi aveva insegnato proprio questo. Nel suo caso avevo eliminato la variabile della collaborazione passando all'apparecchiatura fissa e i denti avevano continuato a muoversi lentamente: **era davvero una *slow mover*.** Ma proprio quell'esperienza mi fece capire anche qualcos'altro. Se una risposta biologica più lenta poteva spiegare realmente una perdita di fitting, allora potevo utilizzare quella stessa possibilità clinica anche quando mi trovavo davanti a un paziente nel quale sospettavo fortemente che il problema fosse invece la collaborazione, senza

doverlo accusare e senza dover dimostrare che mi stesse raccontando qualcosa di diverso da ciò che faceva realmente.

È da lì che, negli anni, è nata una delle strategie che utilizzo più frequentemente.

Non devo dimostrare che il paziente sta mentendo

Quando oggi incontro un paziente con una perdita generalizzata di fitting, non parto più dall'accusa e non cerco immediatamente di convincerlo che non sta utilizzando gli allineatori. Per prima cosa cerco di ricostruire insieme a lui quello che sta succedendo, ripercorrendo le sue abitudini quotidiane e cercando eventuali momenti nei quali gli allineatori rimangono fuori dalla bocca più a lungo di quanto il paziente stesso percepisca. Questo passaggio è importante anche per tutto ciò che abbiamo visto nella prima parte del libro sulla memoria ricostruttiva e sulla differenza che può esistere tra il comportamento reale e il modo in cui ciascuno di noi ricorda e racconta il proprio comportamento.

Se, dopo questa conversazione, il paziente continua ad assicurarmi di utilizzare gli allineatori esattamente come prescritto, non cerco più di dimostrargli il contrario, ma scelgo deliberatamente di accettare la sua versione e introduco un'altra possibile spiegazione:

> *«Guarda, abbiamo due informazioni che dobbiamo mettere insieme. Io vedo che i tuoi denti non stanno seguendo gli allineatori alla velocità che avevamo previsto e tu mi stai dicendo che li stai utilizzando correttamente. Se le cose stanno così, dobbiamo prendere in considerazione un'altra possibilità.»*

Normalmente a questo punto il paziente diventa molto attento, perché non si sente accusato e vuole capire quale possa essere l'altra spiegazione. Continuo:

> *«Non in tutte le persone i denti si spostano alla stessa velocità. La maggior parte dei pazienti risponde nei tempi che utilizziamo normalmente, mentre esiste una piccola percentuale di persone nelle quali la risposta biologica è nettamente più lenta. In letteratura vengono utilizzati anche i termini fast movers e slow movers. Se tu stai davvero utilizzando gli allineatori come mi dici e i denti continuano a rimanere indietro, dobbiamo considerare la possibilità che tu sia uno slow mover.»*

A questo punto non ho contraddetto il paziente e non gli ho chiesto di ammettere nulla. Al contrario, ho preso per buona la sua versione dei fatti, ma proprio perché l'ho accettata devo trarne una conseguenza clinica coerente:

«Se i tuoi denti si muovono più lentamente, una settimana potrebbe non essere sufficiente perché riescano a seguire completamente il movimento programmato in ogni allineatore. Se continuassimo comunque a cambiarli ogni sette giorni, rischieremmo di accumulare progressivamente un ritardo tra la posizione prevista e quella reale dei denti, peggiorando sempre di più il fitting.»

La conseguenza che propongo è semplice:

«Per questo, almeno per il momento, invece di cambiare l'allineatore ogni settimana dovremmo cambiarlo ogni tre settimane. Poi controlleremo come stanno rispondendo i denti e, se vedremo che il fitting migliora, potremo provare progressivamente ad accelerare passando, per esempio, a un cambio ogni due settimane.»

Il cambio ogni tre settimane rappresenta una mia scelta clinica prudenziale e non un intervallo che la letteratura abbia identificato come necessario per tutti i pazienti con una risposta biologica più lenta. Per il paziente, tuttavia, il passaggio da sette a ventuno giorni rende immediatamente concreta una conseguenza che fino a quel momento poteva essere rimasta astratta: se per ogni allineatore dovessimo avere bisogno di tre volte il tempo previsto, mantenendo quel ritmo anche la durata complessiva del trattamento potrebbe diventare addirittura tre volte maggiore.

Ed è proprio a questo punto che, molto spesso, accade la cosa più interessante.

Il paziente rimane qualche secondo a pensarci e comincia spontaneamente a ricostruire il proprio comportamento in maniera un po' diversa:

«Beh, Doc, in effetti ventidue ore proprio sempre forse no. Nel weekend capita che li tenga meno e quando esco magari rimangono fuori più a lungo. Se provo davvero a impegnarmi di più e a utilizzarli sempre, possiamo continuare a cambiarli ogni settimana?»

È importante capire che non gli ho chiesto di confessare nulla. Non gli ho detto che non gli credo e non ho cercato di dimostrare che mi stesse mentendo. Ho semplicemente preso sul serio quello che mi stava raccontando e gli ho mostrato quale sarebbe stata la conseguenza clinica coerente se davvero, nonostante un utilizzo corretto, i suoi denti non fossero riusciti a seguire il ritmo programmato.

Nel momento in cui comprende che questo potrebbe significare passare da sette a ventuno giorni e quindi allungare enormemente il trattamento, cambia anche il modo in cui valuta quelle ore senza allineatori. Quello che fino a pochi minuti prima veniva riassunto con «*li utilizzo sempre*» può diventare «*in effetti, durante il weekend un po' meno*», oppure «*quando esco capita che rimangano fuori parecchio*».

E, quando succede, nella maggior parte dei casi **non passo affatto alle tre settimane**. Se il paziente riconosce spontaneamente che le ore di utilizzo sono state inferiori a quelle prescritte e mi dice di voler provare a essere più preciso, mantengo il cambio settimanale e gli do la possibilità di dimostrarlo attraverso ciò che succederà nelle settimane successive. Le tre settimane rimangono invece la conseguenza clinica coerente quando il paziente continua a confermarmi di avere utilizzato correttamente gli allineatori.

In altre parole, non utilizzo il rallentamento come una punizione. Utilizzo il Tempo per rendere concreta la conseguenza di ciò che sto osservando e permettere al paziente di scegliere se modificare il proprio comportamento.

In questa fase la leva più potente è il Tempo

Come ho già descritto, Tempo, Risultato e Investimento rappresentano tre delle leve che utilizzo più frequentemente nella comunicazione durante un trattamento con allineatori, ma non hanno tutte lo stesso peso in ogni momento della terapia.

Quando il paziente ha iniziato da pochi mesi, utilizzare la leva dell'Investimento ha generalmente poco senso, perché il trattamento è appena iniziato e il paziente ha appena affrontato il costo economico della terapia. Anche il Risultato rimane certamente importante, ma in questa fase può essere ancora relativamente lontano e il paziente può avere difficoltà a percepire quanto una collaborazione insufficiente oggi possa compromettere qualcosa che vedrà soltanto molti mesi dopo. Il Tempo, invece, è immediatamente comprensibile.

Se una persona ha iniziato una terapia sapendo che avrebbe cambiato gli allineatori ogni settimana e che il trattamento sarebbe durato indicativamente quindici o diciotto mesi, sentirsi dire che da quel momento potrebbe essere necessario utilizzare ogni allineatore per tre settimane rende la conseguenza estremamente concreta. Non stiamo più parlando genericamente della possibilità che *«il trattamento si allunghi»*: il paziente vede immediatamente che il ritmo con cui sta procedendo potrebbe diventare tre volte più lento rispetto a quello che aveva immaginato all'inizio.

Per questo spiego:

> *«Inevitabilmente dobbiamo mettere in conto che il trattamento possa allungarsi molto. Se i tuoi denti hanno davvero bisogno di due o tre volte più tempo per seguire ogni allineatore, non possiamo aspettarci di mantenere la durata che avevamo inizialmente previsto. Prima dobbiamo capire qual è il ritmo al quale*

i tuoi denti riescono realmente a seguire gli allineatori e poi potremo fare una previsione più attendibile.»

Non ho bisogno di dire al paziente che una terapia di diciotto mesi durerà sicuramente quattro anni e mezzo, perché non posso saperlo e non sarebbe corretto trasformare una possibile conseguenza in una previsione certa. Posso però fargli capire che, **se il ritmo rimanesse realmente quello di un allineatore ogni tre settimane anziché ogni sette giorni, il tempo necessario potrebbe diventare anche tre volte maggiore**.

Ed è proprio questa differenza tra una conseguenza generica e una conseguenza concreta a rendere la leva del Tempo così efficace. Dire *«se non li porti il trattamento durerà di più»* è qualcosa che il paziente probabilmente ha già sentito e che può rimanere completamente astratto. Passare da sette a ventuno giorni significa invece tradurre quella stessa conseguenza in qualcosa che può vedere, misurare e mettere in relazione con il proprio obiettivo.

Una strategia che funziona in entrambi gli scenari

La caratteristica che più mi interessa di questo approccio è che non ho bisogno di sapere con assoluta certezza quale delle due spiegazioni sia quella corretta.

Se il paziente utilizza realmente gli allineatori ventidue ore al giorno e presenta una risposta biologica particolarmente lenta, rallentare il cambio e rivalutare il fitting rappresenta una scelta prudente e coerente con quello che sto osservando clinicamente.

Se invece, come probabilmente accade nella maggior parte delle situazioni nelle quali utilizzo questa strategia, il paziente utilizza gli allineatori molte meno ore di quelle che dichiara, non l'ho accusato di mentire e non l'ho costretto a difendersi. Gli ho semplicemente mostrato una conseguenza del comportamento attuale che per lui è immediatamente rilevante.

Molto spesso è proprio questo che porta alla revisione spontanea del suo racconto. Il paziente non ha bisogno di passare bruscamente da *«li utilizzo sempre»* a *«ti stavo mentendo»*. Può semplicemente fermarsi, ripensare alla propria settimana e riconoscere che forse quel *sempre* non significava davvero ventidue ore ogni giorno. Se a quel punto decide di impegnarsi maggiormente, posso mantenere il cambio settimanale e verificare se alle parole seguirà effettivamente un comportamento diverso.

Se invece continua a sostenere che le ore di utilizzo sono già corrette, non ho motivo di discutere: accetto quella spiegazione, rallento il cambio e verifico la risposta.

In entrambi i casi ho ottenuto ciò che mi interessava davvero: **una decisione concreta su quello che succederà da quel momento in avanti.**

La confessione non muove i denti

Credo che questo sia stato uno dei cambiamenti più importanti nel mio modo di comunicare con i pazienti poco collaboranti. Per molto tempo ho pensato che il mio compito fosse riuscire a far capire al paziente che non stava facendo ciò che gli avevo chiesto, quasi come se l'ammissione dell'errore rappresentasse una condizione necessaria per poter ripartire correttamente. Con il tempo, però, ho capito che ottenere quell'ammissione non era affatto ciò di cui avevo bisogno.

Paradossalmente, oggi quella sorta di confessione arriva più frequentemente proprio perché ho smesso di cercarla. Quando il paziente non si sente messo sotto accusa e comprende invece la conseguenza concreta di ciò che stiamo osservando, può permettersi di riconsiderare il proprio comportamento senza vivere quel cambiamento di versione come una sconfitta.

Se mi dice «*In effetti nel weekend li ho utilizzati meno, però da oggi mi impegno davvero*», quella informazione mi è certamente utile, perché mi consente di mantenere il cambio settimanale e verificare se una migliore collaborazione sia sufficiente a recuperare il fitting. Ma non è la confessione ad avere valore terapeutico: è ciò che il paziente farà dopo.

Se dopo dieci minuti di discussione riuscissi invece a costringerlo ad ammettere «*Hai ragione, in realtà li portavo dodici ore al giorno*», avrei forse la soddisfazione di sapere che avevo interpretato correttamente il fitting, ma dal punto di vista clinico non avrei ancora ottenuto ciò che mi interessa davvero. **La confessione non muove i denti, mentre un cambiamento di comportamento sì.**

La strategia dello *slow mover* permette al paziente di modificare il proprio comportamento senza costringerlo ad ammettere che ciò che mi aveva raccontato fino a pochi minuti prima non fosse completamente vero. Gli offre la possibilità di salvare la faccia, ma contemporaneamente gli rende molto più difficile ignorare la conseguenza di continuare nello stesso modo.

Se mettiamo una persona nella condizione di dover scegliere tra ammettere di non avere seguito le nostre indicazioni e continuare a difendere la propria versione, può scegliere la seconda possibilità anche quando questo non la aiuta affatto

a raggiungere il risultato che desidera. Se invece eliminiamo quella discussione e spostiamo l'attenzione sulle conseguenze cliniche e sulle possibili soluzioni, le permettiamo di cambiare comportamento senza dover prima riconoscere apertamente di avere sbagliato.

Per questo, quando l'evidenza clinica e il racconto del paziente non coincidono, oggi cerco molto meno di stabilire chi abbia ragione e molto di più di trovare una strategia che possa funzionare indipendentemente dalla spiegazione. **Non abbiamo bisogno di dimostrare al paziente che abbiamo ragione; abbiamo bisogno di creare le condizioni perché possa iniziare a fare la cosa giusta.**

SCRIPT OPERATIVO

Quando osservo una perdita generalizzata di fitting, dopo avere ricostruito insieme al paziente le sue abitudini e avere ricevuto la conferma che gli allineatori vengono utilizzati correttamente, la conversazione può essere impostata in questo modo:

> *«Vedo che diversi denti non stanno seguendo gli allineatori alla velocità che avevamo previsto. Abbiamo cercato di capire insieme come li stai utilizzando e tu mi confermi che li porti correttamente, quindi dobbiamo prendere in considerazione un'altra possibilità. Non in tutte le persone i denti si muovono alla stessa velocità e ci sono pazienti nei quali la risposta biologica al movimento ortodontico è più lenta. In letteratura vengono utilizzati anche i termini fast movers e slow movers e, se tu stai realmente utilizzando gli allineatori come mi dici, è possibile che tu appartenga a questo secondo gruppo.*
>
> *Se i tuoi denti si muovono più lentamente, una settimana potrebbe non essere sufficiente perché riescano a seguire completamente la posizione prevista da ogni allineatore. Se continuassimo a cambiarli ogni sette giorni, questo piccolo ritardo potrebbe aumentare progressivamente e il fitting peggiorerebbe sempre di più. Per questo, se le ore di utilizzo sono davvero quelle che mi hai indicato, dobbiamo dare ai denti più tempo e passare, almeno inizialmente, da una settimana a tre settimane per ogni allineatore.*
>
> *Questo significa che il ritmo del trattamento diventerebbe tre volte più lento. Non posso dirti oggi che l'intera terapia durerà tre volte tanto, perché dobbiamo prima vedere come rispondono i denti e potremo eventualmente accelerare di nuovo, ma se dovessimo mantenere questo ritmo per tutto il trattamento anche la durata complessiva potrebbe aumentare in maniera molto importante. Adesso dobbiamo*

> *quindi capire qual è il ritmo con cui i tuoi denti riescono realmente a seguire gli allineatori.»*

A questo punto lascio spazio al paziente. Se mi dice:

> *«Doc, in effetti forse non sono sempre ventidue ore. Se mi impegno davvero, possiamo provare a mantenere il cambio settimanale?»*

la mia risposta può essere altrettanto semplice:

> *«Certo. Se pensi che ci siano state delle ore che possiamo recuperare, preferisco darti questa possibilità. Continuiamo con il cambio settimanale, ma da oggi dobbiamo essere molto precisi. Al prossimo controllo sarà il fitting a dirci se questa modifica è stata sufficiente.»*

Se invece continua a confermarmi che le ore di utilizzo sono già corrette, non insisto e non cerco di fargli cambiare versione: applico il rallentamento che gli ho spiegato e verifico successivamente la risposta.

Perché questo protocollo funziona

- **Riduzione della reattanza**

Contraddire direttamente il paziente e dirgli che non sta utilizzando gli allineatori come sostiene può spingerlo a difendere ancora di più la propria posizione. Accettare inizialmente la sua versione e proporre una spiegazione alternativa evita lo scontro e mantiene la conversazione concentrata sulla soluzione del problema.

- **Salvare la faccia**

La strategia dello *slow mover* permette al paziente che ha utilizzato poco gli allineatori di modificare il proprio comportamento senza essere costretto ad ammettere di avere mentito. Può semplicemente riconsiderare il significato del suo *«sempre»* e riconoscere che alcune ore sono state perse. In questo modo il cambiamento di comportamento non richiede prima una sconfitta personale.

- **Salienza della conseguenza**

Dire *«devi utilizzarli di più»* indica ciò che dovrebbe fare, ma non rende necessariamente evidente perché dovrebbe farlo. Passare da sette a ventuno giorni traduce invece la conseguenza in qualcosa di immediatamente comprensibile.

■ **Leva del Tempo**

Nelle prime fasi del trattamento l'Investimento è stato appena sostenuto e il Risultato finale può essere ancora lontano, mentre il Tempo rappresenta una conseguenza vicina e facilmente comprensibile. La prospettiva di procedere a un ritmo tre volte più lento può cambiare rapidamente il valore attribuito a quelle ore nelle quali gli allineatori vengono lasciati fuori.

■ **Feedback**

Il protocollo non termina con la conversazione. Se il paziente decide di mantenere il cambio settimanale impegnandosi maggiormente, il fitting al controllo successivo diventa il feedback che ci permette di verificare se il cambiamento di comportamento sia stato sufficiente. Se invece rallentiamo il cambio e il fitting continua a non migliorare, dobbiamo essere disponibili a riconsiderare anche la nostra ipotesi clinica.

BIBLIOGRAFIA

Giannopoulou C, Dudic A, Pandis N, Kiliaridis S. Slow and fast orthodontic tooth movement: an experimental study on humans. *European Journal of Orthodontics.* 2016;38(4):404–408.

Bertl K, Neuner H, Meran A, et al. Does the time-point of orthodontic space closure initiation after tooth extraction affect the incidence of gingival cleft development? A randomized controlled clinical trial. *Journal of Periodontology.* 2020;91(5):572–581.

Küchler EC, Schröder A, Corso P, et al. Genetic polymorphisms influence gene expression of human periodontal ligament fibroblasts in the early phases of orthodontic tooth movement. *Odontology.* 2020;108:493–502.

Adattare la comunicazione al profilo DISC

D

Dominante

Leva principale: tempo e controllo.

Con un paziente dominante eviterei il confronto diretto, perché mettere in discussione apertamente ciò che ci sta raccontando rischia di trasformare rapidamente il colloquio in una sfida. È più efficace presentare le due possibilità in maniera chiara, lasciando che sia il comportamento successivo a determinare quale strada potremo seguire.

> *«Se le ore sono già quelle corrette, dobbiamo rallentare perché i tuoi denti hanno bisogno di più tempo. Se invece pensi che ci sia margine per essere più preciso, possiamo mantenere il cambio settimanale e verificare subito se recuperiamo il fitting. Al prossimo controllo avremo la risposta.»*

Adattare la comunicazione al profilo DISC

SEGUE

I

Influente

Leva principale: risultato e motivazione.

Con un paziente influente eviterei una spiegazione troppo lunga o tecnica, concentrandomi maggiormente sulla possibilità di recuperare rapidamente la situazione e mantenere il ritmo iniziale se riesce a modificare concretamente il comportamento.

> *«Possiamo ancora provare a mantenere il cambio settimanale. Se sai che in alcune giornate li hai utilizzati meno, da oggi recuperiamo quelle ore e vediamo come reagiscono i denti. Se al prossimo controllo il fitting è tornato quello che vogliamo, continuiamo così.»*

S

Stabile

Leva principale: rassicurazione e percorso.

Con un paziente stabile è importante evitare che la situazione venga interpretata come il segnale che il trattamento stia fallendo. Spiegherei quindi che abbiamo due possibili strade e che entrambe possono essere controllate nel tempo.

> *«Non significa che il trattamento non stia funzionando. Dobbiamo soltanto capire se i denti hanno bisogno di più tempo oppure se possiamo recuperare qualche ora di utilizzo. Se pensi di poter essere più preciso, continuiamo per ora con il cambio settimanale e al prossimo controllo vediamo insieme come stanno rispondendo.»*

C

Coscienzioso

Leva principale: dati e spiegazione.

Con un paziente coscienzioso utilizzerei maggiormente ciò che possiamo osservare clinicamente, mostrando il fitting e spiegando con precisione le due ipotesi e il modo in cui il controllo successivo ci permetterà di distinguerle.

> *«Clinicamente vediamo che i denti sono rimasti indietro rispetto alla posizione prevista. Se le ore di utilizzo sono già corrette, dobbiamo considerare una risposta biologica più lenta e aumentare il tempo di ogni allineatore. Se invece pensi che ci siano state delle ore di utilizzo mancanti, possiamo mantenere per ora il cambio settimanale, correggere quel dato e verificare al prossimo controllo se la discrepanza si riduce.»*

CAPITOLO 6

Protocollo in sintesi

QUANDO APPLICARLO	Al primo controllo della sequenza, normalmente dopo circa due mesi, quando compare una perdita progressiva e generalizzata di fitting. Valutare anche programmazione e risposta biologica prima di attribuirla alla collaborazione.
OBIETTIVO	Recuperare il fitting modificando il comportamento o l'intervallo di cambio e verificando la risposta.
COSA FARE	1. Ricostruire la giornata: pasti, lavoro, serate, weekend e tempo trascorso prima di reinserire gli allineatori. 2. Se il paziente conferma un utilizzo corretto, considerare anche una risposta biologica più lenta. 3. Prospettare il passaggio da sette a ventuno giorni, spiegando che rallenterebbe significativamente il trattamento. Ventuno giorni è una scelta del protocollo descritto, non una prescrizione universale. 4. Se riconosce un utilizzo insufficiente, concordare le ore prescritte e mantenere il cambio settimanale quando le condizioni cliniche lo consentono. 5. Se conferma un utilizzo corretto, rallentare il cambio e rivalutare il fitting, decidendo successivamente se mantenere il ritmo o accelerare. 6. Se il fitting non migliora, riconsiderare anche l'ipotesi clinica iniziale.
COSA VERIFICARE	Distribuzione della perdita di fitting, ore e routine di utilizzo, intervallo di cambio e risposta al controllo successivo. Una promessa di maggiore impegno deve essere seguita da un cambiamento verificabile.